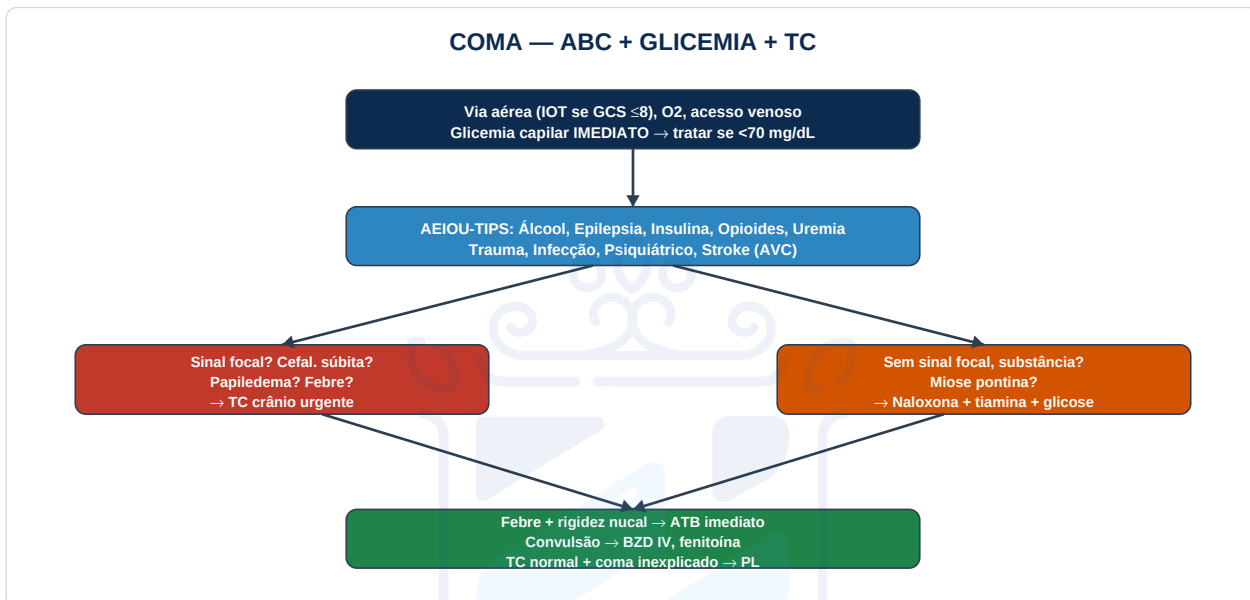


COMA — CAUSA E CONDUTA RÁPIDA

ABORDAGEM INICIAL — COMA NO PS



ESCALA DE COMA DE GLASGOW (GCS)

Domínio	Resposta	Pontos
Ocular (E)	Espontânea / A voz / À dor / Nenhuma	4 / 3 / 2 / 1
Verbal (V)	Orientado / Confuso / Palavras / Sons / Nenhum	5 / 4 / 3 / 2 / 1
Motor (M)	Obedece / Localiza / Flexão normal / Flexão anormal / Extensão / Nenhum	6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1
GCS ≤8	= Coma clínico — considerar proteção de via aérea (IOT)	—
GCS ≤13	= Rebaixamento significativo — monitorar, buscar causa	—

SM24
Suporte ao Plantão Médico

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL — CAUSAS DE COMA

Causa	Achados-chave	Diagnóstico / Tratamento
Hipoglicemia	Diaforese, tremor, Hgt <70 mg/dL	Glicose 50% 40-80 mL IV + tiamina 100mg IV
AVC (isquêmico/hemorrágico)	Déficit focal, HAS, início súbito	TC sem contraste → trombólise vs neurocirurgia
HSA (hemorragia subaracnóide)	Cefaleia em 'trovão', rigidez nuchal	TC sem contraste → PL se TC normal
Meningite/Encefalite	Febre + rigidez nuchal + fotofobia	ATB + dexametasona; aciclovir se encefalite
Intoxicação (opioide)	Miose, bradipneia, cianose	Naloxona 0,4-2 mg IV/IN; repetir
Estado epiléptico não-convulsivo	Coma sem crise motora aparente	EEG contínuo; BZD + fenitoína/levetiracetam
Encefalopatia hepática	Asterixe, flapping, fator hepático	Lactulose, tratar causa, retirar proteína excessiva
Hipercapnia / hipóxia	Cianose, SpO2 baixa, paciente DPOC	VNI ou VM; O2 controlado no DPOC

EXAME NEUROLÓGICO DO COMA — PUPILAS + MOTRICIDADE**O QUE LOCALIZA A LESÃO**

- Pupilas midriáticas fixas bilaterais: lesão mesencefálica grave, anóxia cerebral, atropina
- Pupilas mióticas bilaterais (puntiformes): intoxicação por opioide, lesão pontina
- Pupila unilateral dilatada e fixa: herniação uncal ipsilateral — emergência cirúrgica
- Reflexo oculocefálico (olhos de boneca): tronco intacto = causa metabólica/tóxica
- Postura de decorticação (flexão): lesão acima do mesencéfalo
- Postura de descerebração (extensão): lesão no mesencéfalo/tronco — pior prognóstico

TRÍADE ANTÍDOTO EMPÍRICA**Glicose + Tiamina + Naloxona**

- Glicose 50%: 40-80 mL IV se Hgt <70 ou não dosável
- Tiamina 100 mg IV SEMPRE antes da glicose (Wernicke)
- Naloxona 0,4-2 mg IV/IM/IN: suspeita de opioide
- Flumazenil: raramente — risco de convulsão (benzodiazepínico)
- Piridoxina 5g IV: intoxicação por isoniazida

Sinais de Herniação — Urgência Máxima

- Pupila unilateral dilatada + coma = herniação uncal
- Postura de descerebração bilateral
- Tríade de Cushing: HAS + bradicardia + respiração irregular
- Conduta: cabeceira 30°, manitol 1g/kg IV rápido
- Hiperventilação (PCO2 30-35) como ponte para cirurgia
- Neurocirurgia urgente: hematoma evacuável

CHECKLIST — COMA INEXPLICADO

SISTEMATIZAR A INVESTIGAÇÃO

- ☐ GCS + pupilas + padrão motor (decorticação/descerebração?) + reflexos tronco
- ☐ Glicemia IMEDIATA + tiamina + naloxona empírico se suspeita de opioides
- ☐ TC crânio sem contraste urgente se déficit focal, cefaleia súbita, trauma, febre
- ☐ Eletrólitos, função renal, hepática, hemograma, gasometria, NH3 (amônia), toxicológico
- ☐ EEG se TC normal e coma persistente (excluir estado epiléptico não-convulsivo)
- ☐ PL se TC normal, febre ou suspeita de HSA com TC negativa
- ☐ Documentar causa e progredir suporte: via aérea, PA, temperatura, glicemia



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente em coma, miose bilateral intensa, bradipneia e cianose. Qual é o diagnóstico mais provável e o tratamento imediato?

- A) AVC hemorrágico — TC + neurocirurgia
- B) Intoxicação por opioide — naloxona 0,4-2 mg IV
- C) Crise epiléptica — diazepam 10 mg IV
- D) Hipoglicemia — glicose 50% IV
- E) Meningite — ceftriaxona IV

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Por que a tiamina (vitamina B1) deve ser administrada ANTES da glicose em paciente desnutrido em coma?

- A) A tiamina aumenta a absorção da glicose
- B) Glicose sem tiamina pode precipitar encefalopatia de Wernicke em pacientes com deficiência de tiamina
- C) A tiamina reverte o efeito tóxico da glicose
- D) Não há necessidade — podem ser dados em qualquer ordem
- E) A tiamina é um antídoto para hipoglicemia

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Paciente em coma com pupila direita dilatada e fixa, hemiplegia esquerda. Qual é o mecanismo fisiopatológico?

- A) Lesão no nervo óptico direito
- B) Herniação uncal do lobo temporal direito comprimindo o III nervo craniano
- C) AVC isquêmico em território vertebrobasilar
- D) Hipoglicemia grave bilateral
- E) Intoxicação por atropina

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Um paciente em coma com TC normal, febre e rigidez nuchal aguarda resultado de PL. Qual a conduta CORRETA enquanto espera?

- A) Aguardar o resultado da PL antes de qualquer tratamento
- B) Iniciar ceftriaxona 2g IV + dexametasona imediatamente, sem atrasar pelo resultado
- C) Realizar RMC antes da PL
- D) Administrar aciclovir IV apenas após PCR positivo no LCR
- E) Apenas observar e repetir TC em 6h

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Qual achado no exame do coma indica comprometimento do tronco cerebral (não de causa metabólica)?

- A) Reflexo oculocefálico (olhos de boneca) preservado bilateralmente
- B) Hipoglicemia com reversão ao glicose IV
- C) Ausência do reflexo oculocefálico e pupilas fixas bilaterais
- D) GCS de 10 com agitação
- E) Asterixe bilateral

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Miose bilateral intensa (pupilas puntiformes) + bradipneia + cianose = toxidrome opiáceo. Tratamento: naloxona 0,4-2mg IV, repetir a cada 2-3 min. Efeito em 1-2 min. Infusão contínua para opioides de longa ação (metadona).

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Em desnutridos/alcoolistas, a glicose pode consumir o restante de tiamina (B1) e precipitar Encefalopatia de Wernicke (oftalmoplegia, ataxia, confusão). Sempre: tiamina 100mg IV ANTES ou junto da glicose.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Pupila dilatada unilateral + coma = herniação uncal do lobo temporal ipsilateral → compressão do nervo oculomotor (III), que tem fibras parassimpáticas externas (midríase). Emergência neurocirúrgica: manitol 1g/kg + TC urgente.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Suspeita de meningite bacteriana: ATB + dexametasona IMEDIATAMENTE, antes do resultado da PL. Atrasar o antibiótico aumenta mortalidade e sequelas. PL deve ser feita mas não deve atrasar o tratamento.

QUESTÃO 5 → Resposta: C

Reflexo oculocefálico (olhos de boneca) preservado = tronco intacto = causa metabólica/tóxica. Ausência do reflexo + pupilas fixas = lesão estrutural do tronco. Asterixe = encefalopatia metabólica (não focal).

SM24
Suporte ao Plantão Médico